

INDICADO POR:			
☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA			
NS 22242217555 803			
REYNALDO DE FARIA BRIZON			
IDADE: 52	PESO:	ALTURA:	PROFISSÃO: Empresário 8-17hr
SINTOMAS:			
QUEIXAS: não tem queixa (esposa reclama barulho)			
MEDICAMENTOS:			
MÉDICO:			
MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N			
EXERCÍCIO FÍSICO: sim			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S		ALMOÇO:	LANCHE: — JANTAR: 19:30
HORA QUE DORME: 22:30		HORA QUE ACORDA: 6:30 (acorda 4:30-5hr)	
COCHILHO () S () N	DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE		
TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N		PET NO QUARTO: () S () N	
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N			
FUMO: () S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO/NOITE: 1X	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI:	IAH: 30 e 1h	SPO2: 82%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA	(S) NEUROLÓGICA	() OUTROS:	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: ☒ S () N		SPO2 C/ CPAP: 5(82) PRESSÃO NO EXAME: 6	
21/07/2025 - Avaliação. Arc.			
28/10/2025 = P = 6,10 cmH ₂ O. Refere sono			
IAH = 0,2 e 1h			
m. uso = 8 horas. signa			
fluxo = 6 l/min.			
04/08/25 P = 6 cmH ₂ O Hoje ele relata que tinha			
IAH = 0,3 sonolência / e menos um.			
m. de uso = 7h37'			
fluxo = 90 l/min. Arc.			

Reynaldo de Faria Byn

Soluto

Cidre de CPM p/ parte aré

C/ Apria do sono (30/hea / C/ CPM

indico qd beber a parte de

6 cm / hea

DRA CATHARINA SOARES DE ANDRADE
Otorrinolaringologista
Crim. 14436

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: REYNALDO DE FARIA BRIZON

Sexo: Masculino

Data do Exame: 12-04-2025

Idade: 51 anos

Peso: 82 kg

Altura: 1.85 m

Médico Solicitante: DRA. CATHARINA SOARES DE ANDRADE

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 12/04/2025 21:27 e finalizado às 13/04/2025 05:43.

A latência para início do sono foi de 7,0 min e a latência para o sono REM de 67,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 381,5 min, com eficiência do sono de 76,8 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 1,3 % de estágio N1, 51,4 % de estágio N2, 22,8 % de estágio N3 e 24,5 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 108,0 min. Ocorreram 19 despertares, sendo o índice de 2,3 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 11, sendo 1 apneia obstrutiva, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 10 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 1,7 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 0,6 e o IDR durante o sono NREM foi de 2,1. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 1,7 (nº/h), sendo 0,2 apneia/h e 1,6 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 95%, a média de 95% e a mínima de 92%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 1,3 (nº/h), sendo que em REM foi de 0,6 (nº/h) e em NREM foi de 2,1 (nº/h). Permaneceu 0,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Reynaldo de Faria Brizon

EXAME nº: 5769

SOLICITADO POR: Dra. Catharina Soares de Andrade

DATA: 21/11/2024

IDADE: 51 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h23min e concluído às 05h58min. A latência para o sono foi de 3 minutos e a latência para o estágio REM, de 65 minutos. O tempo total de sono foi de 426 minutos (07h06min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 93,6%. A distribuição do sono mostrou 6,5% de estágio 1, 49,3% de estágio 2, 18% de estágio 3 e 26,3% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 25,5 minutos em vigília, ocorreram 31 microdespertares (Índice: 4,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0,7/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 30,6/hora, sendo 1 apneia/hora e 29,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 36,5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 94% e a mínima de 82%.

(*) TTS = Tempo Total de Sono TTR = Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (30,6/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (36,5/hora), algumas dessaturações da oxi-hemoglobina e o ritmo cardíaco foi sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 49; máxima: 62 bpm.

O ronco foi contínuo e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 3 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (65 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (93,6%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (4,4/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 3 (18%; normal: 10-12%) e REM (26,3%; normal: 20%), e a redução do estágio 1 (6,5%; normal: 8-10%). A porcentagem do estágio 2 (49,3%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (0,7/hora; normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Escala de Sonolência de Epworth: 16 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).